

TEMA 5.18 • HEMATOLOGÍA

Coagulación Intravascular Diseminada (CID)

PERFIL EUNACOM 1.07.2.008

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Coagulación Intravascular Diseminada (CID)

Definición

Activación sistémica de la coagulación → consumo masivo de plaquetas y factores de coagulación → **trombosis + hemorragia** simultáneas.

Causas

- **Sepsis** (más frecuente)
- Leucemia aguda (LMA, LLA)
- Preeclampsia grave, desprendimiento placentario, líquido amniótico
- Politraumatismo, gran quemado
- Pancreatitis aguda grave, neoplasias sólidas

Clínica

- **Hemorragia** (petequias, sangrado en sitios de punción, hemorragia de mucosas)
- **Trombosis** (isquemia de órganos: renal, cerebral, hepática)
- **Anemia: Generalidades** | **Anemia** hemolítica microangiopática (esquistocitos)

Diagnóstico

TABLA 5.18.1: EXAMEN VS HALLAZGO	
EXAMEN	HALLAZGO
Plaquetas	↓ (consumo)
TP / INR	↑ (consumo factores vía extrínseca)
TTPK	↑ (consumo factores vía intrínseca)
Fibrinógeno	↓ (consumo — clave)
Dímero D	↑↑ (productos de degradación del fibrinógeno)

EUNACOM CRITERIOS

La combinación fibrinógeno ↓ + dímero D ↑ es el dato más específico de CID (además de la clínica del paciente crítico).

Tratamiento

- **Tratar la causa** (ej: parto en preeclampsia, ATB en sepsis)
- **Soporte** intensivo de complicaciones (respiratorio, renal, hemodinámico)
- Reposición cautelosa:
 - - Plaquetas si sangrado activo grave + plaquetas < 50.000
 - - Plasma fresco congelado (PFC) si sangrado + ↑ TP y TTPK
 - - Crioprecipitado (fibrinógeno) si fibrinógeno < 1 g/L
- **No dar** ácido tranexámico ni fibrinolíticos rutinariamente

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente séptico con hemorragias múltiples, plaquetas de 30.000/mm³, TTPA y TP alargados, fibrinógeno de 80 mg/dL (bajo) y dímero D de 5.000 ng/mL (elevado). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Coagulación Intravascular Diseminada (CID). Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La CID es complicación del paciente crítico: sepsis, preeclampsia, leucemias, politraumatismo, gran quemado
- Clínica: suma de trombosis diseminada + hemorragias por consumo de plaquetas y factores
- Exámenes: tiempos de coagulación alargados, plaquetas bajas, fibrinógeno bajo, dímero D elevado
- La combinación fibrinógeno bajo + dímero D elevado es lo más orientador para CID
- Frecuentemente se asocia anemia hemolítica microangiopática
- Tratamiento: soporte + causa + reposición cautelosa de plaquetas/plasma
- NO se recomienda ácido tranexámico ni fibrinolíticos
- La reposición de plaquetas y plasma se hace con cautela por riesgo de avivar la trombosis

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA (CID))**PREGUNTA 1**

Paciente séptico con hemorragias múltiples, plaquetas de $30.000/\text{mm}^3$, TTPA y TP alargados, fibrinógeno de 80 mg/dL (bajo) y dímero D de 5.000 ng/mL (elevado). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** PTI
- B)** PTT
- C)** Coagulación intravascular diseminada
- D)** Hemofilia A
- E)** Déficit de vitamina K

PREGUNTA 2

En la CID, ¿cuál es la combinación de laboratorio más orientadora?

- A)** TTPA alargado + plaquetas normales
- B)** Fibrinógeno bajo + dímero D elevado
- C)** TP alargado + TTPA normal
- D)** Plaquetas bajas + fibrinógeno elevado
- E)** Dímero D bajo + plaquetas altas

PREGUNTA 3

¿Cuál de los siguientes tratamientos está CONTRAINDICADO en la CID?

- A)** Plasma fresco congelado
- B)** Transfusión de plaquetas
- C)** Ácido tranexámico
- D)** Tratamiento de la causa subyacente
- E)** Soporte hemodinámico

RESUMEN: COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA (CID)

Esta clase cubre la coagulación intravascular diseminada (CID), una complicación grave del paciente crítico y de las neoplasias. Las causas incluyen sepsis, preeclampsia, leucemias, otros cánceres, pancreatitis aguda, politraumatismo y gran quemado. La clínica es la suma de trombosis diseminada más hemorragias, ya que los fenómenos trombóticos consumen plaquetas y factores de coagulación. El diagnóstico se basa en la clínica más exámenes: tiempos de coagulación alargados, plaquetas bajas, fibrinógeno bajo y dímero D elevado (la combinación de fibrinógeno bajo + dímero D elevado es lo más orientador). El tratamiento es complejo: soporte de las complicaciones, tratamiento de la causa, reposición cautelosa de plaquetas y plasma fresco congelado (con el riesgo de avivar la trombosis), eventual anticoagulación y evitar el ácido tranexámico y los fibrinolíticos.